



Iridotomie périphérique au laser (IPL)

L'iridotomie périphérique au laser (IPL) est une procédure utilisée pour traiter ou prévenir le glaucome par fermeture de l'angle. Elle utilise un laser focalisé pour créer un minuscule trou dans l'iris (la partie colorée de l'œil), permettant au liquide de circuler plus librement et de réduire la pression intraoculaire.

Pourquoi cette procédure est-elle réalisée ?

L'IPL est généralement recommandée chez les patients qui :

- Ont des angles de drainage étroits
- Sont à risque de glaucome par fermeture de l'angle
- Ont déjà connu une élévation soudaine de la pression intraoculaire (fermeture aiguë de l'angle)

Elle permet de créer une voie alternative pour le liquide intraoculaire, soulageant ainsi la pression et prévenant la perte de vision.

À quoi s'attendre pendant la procédure ?

- L'IPL est réalisée en clinique ou en salle de laser
- Des gouttes seront utilisées pour **rétrécir votre pupille** et **anesthésier l'œil**
- Une **lentille spéciale** est placée sur l'œil pour aider à concentrer le laser
- Le laser crée un petit trou dans l'iris — cela ne prend que quelques minutes
- Vous pouvez ressentir une **petite piqûre ou une légère sensation de brûlure**

Après la procédure

- La pression oculaire sera vérifiée peu après
- Vous recevrez peut-être des **gouttes anti-inflammatoires** pendant quelques jours
- La vision peut être **brouillée** ou vous pouvez être **sensible à la lumière** temporairement
- Certaines personnes voient de **petites ombres** ou des **lueurs lumineuses** qui s'estompent avec le temps



Effets secondaires possibles

L'IPL est généralement sûre, mais comme toute procédure, elle comporte certains risques :

- Vision floue ou inconfort temporaire
- Inflammation (traitée avec des gouttes)
- Sensibilité à la lumière ou éblouissement
- Dans de rares cas, augmentation de la pression ou petit saignement

Foire aux questions (FAQ)

Q : L'IPL est-elle douloureuse ?

R : La plupart des patients ressentent seulement un léger inconfort — le laser est rapide et rarement douloureux.

Q : Aurai-je encore besoin de médicaments contre le glaucome ?

R : Possiblement. L'IPL améliore l'anatomie de l'angle mais ne remplace pas toujours les gouttes ou autres traitements.

Q : Devrai-je faire l'IPL dans les deux yeux ?

R : Si les deux yeux présentent des angles étroits, votre médecin peut recommander une IPL bilatérale — parfois le même jour ou à quelques semaines d'intervalle.

Q : Le trou reste-t-il ouvert en permanence ?

R : Dans la plupart des cas, oui. Rarement, il peut se refermer et nécessiter une nouvelle ouverture.